TOME 24 • RÉFÉRENTIEL CONCOURS R2C

Oto-Rhino-Laryngologie (ORL)

Collège Français d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale • 230 pages

Extrait de prévisualisation officielle du Tome 24 : Oto-Rhino-Laryngologie (ORL).

Cet extrait contient une sélection représentative de fiches de synthèse, de tableaux diagnostiques et de repères méthodologiques indispensables pour la préparation des Épreuves Dématérialisées Nationales (EDN) et des Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré (ECOS).

- **Volume complet :** 230 pages A4 grand format.
- **Éditeur & Collège :** Collège Français d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale.
- **Classification pédagogique :** Rangs A (Socle obligatoire pour tous) et Rangs B (Différenciation de spécialité).
- **Supports didactiques :** Tableaux décisionnels, arbres diagnostiques, posologies de première intention et pièges zéros.

Spécification	Détail Officiel
Format	PDF vectoriel haute résolution optimisé grand écran et tablette
Pagination totale	230 pages complètes non tronquées
Mises à jour	Conforme dernières conférences de consensus HAS & R2C 2026
Épreuves ciblées	EDN (QCMs, KFP, TCS) et ECOS (Stations pratiques 7 min)

PRÉSENTATION DU RÉFÉRENTIEL • TOME 24

Collège Français d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale • Réforme R2C 2026

Le programme officiel du 2e Cycle des études médicales structure les connaissances cliniques selon une hiérarchisation stricte en **deux niveaux de maîtrise** :

• **Rang A (Indispensable pour tout futur médecin) :** Représente le socle des connaissances incontournables. Tout interne, quelle que soit sa spécialité future, doit maîtriser ces items à la perfection (définitions, urgences vitales, signes cardinaux, thérapeutiques de première ligne et conduites à tenir d'extrême urgence). Une impasse sur un Rang A est sanctionnée par des points de pénalité majeurs lors des EDN.

• **Rang B (Connaissances approfondies de spécialité) :** Constitue le niveau discriminant pour les classements d'accès aux postes d'internat les plus sélectifs. Il aborde les subtilités physiopathologiques, les protocoles de deuxième et troisième lignes, les posologies hospitalières complexes et les examens paracliniques spécialisés.

Méthodologie pédagogique adoptée dans ce volume :
1. **Fiches synthétiques standardisées :** Chaque chapitre débute par le rappel des objectifs terminaux du Collège.
2. **Mise en valeur visuelle :** Balises Rang A (en surbrillance verte) et Rang B (en surbrillance bleue).
3. **Points de vigilance & Pièges de concours :** Encarts dédiés aux confusions fréquentes retrouvées dans les annales officielles.
4. **Tableaux comparatifs synthétiques :** Condensé de données permettant une révision rapide en quelques minutes.

RAPPEL IMPORTANT POUR L'ÉPREUVE EDN :
Les Questions Isolées (QI), Dossiers Progressifs (DP) et Tests de Concordance de Script (TCS) reposent à 100% sur les données publiées par le Collège officiel. Les traités anciens ou les sources non harmonisées comportent souvent des discordances susceptibles d'entraîner des pertes de points sévères.

SOMMAIRE DU RÉFÉRENTIEL COMPLET

Tome 24 • Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) (230 pages)

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU MODULE

- Chapitre 01 : Surdité (89)
- Chapitre 02 : Vertiges (103)
- Chapitre 03 : Otites (150)
- Chapitre 04 : Fracture du rocher (334)
- Chapitre 05 : Angines (Amygdalite aiguë) (149)
- Chapitre 06 : Dysphonie (88)
- Chapitre 07 : Tumeurs ORL (298)
- Chapitre 08 : Épistaxis (87)
- Chapitre 09 : Infections nasosinusiennes (148)
- Chapitre 10 : Paralysie faciale (101)
- Chapitre 01 — Surdité (89)
- Examens fonctionnels de l’audition
- Acoumétrie
- Schéma
- • cf collège principes d’acoumétrie au diapason
- Audiométrie tonale
- Schéma
- • cf collège : différentes types de surdité en audiométrie tonale
- Audiométrie vocale
- Exemple collège
- Seuil d’intelligibilité à 20 dB, Maximum d’intelligibilité à 30 dB
- Impédancemétrie
- Images de Tympanogramme
- • cf collège : différents résultats possibles de l’impédancemétrie
- Potentiels évoqués auditifs précoces (PEAP), dits du tronc cérébral
- Exemple collège
- Otoémissions acoustiques (OEA) : rang C

EXTRAIT DIDACTIQUE DU COURS

Concepts Clés & Sémiologie Didactique • Rangs A et B

Chapitre 01 : Surdité (89)
Chapitre 02 : Vertiges (103)
Chapitre 03 : Otites (150)
Chapitre 04 : Fracture du rocher (334)
Chapitre 05 : Angines (Amygdalite aiguë) (149)
Chapitre 06 : Dysphonie (88)
Chapitre 07 : Tumeurs ORL (298)
Chapitre 08 : Épistaxis (87)
Chapitre 09 : Infections nasosinusiennes (148)
Chapitre 10 : Paralysie faciale (101)

Chapitre 01 — Surdité (89)

Examens fonctionnels de l’audition

Acoumétrie

Schéma

- cf collège principes d’acoumétrie au diapason

Audiométrie tonale

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • I

Synthèse Diagnostique & Critères de Classification • Oto-Rhino-Laryngologie (ORL)

Paramètre 1	Définitions
Surdité	Sympto■me de■fini par une baisse de l'audition, quelle que soit son importance, quelle que soit son e■tiologie -> signes d'appels : baisse de l'audibilité (je n'entends pas) ou baisse de l'intelligibilité (je ne comprends pas)
Hypoacousie	Synonyme de surdité, souvent employe■ pour les surdite■s le■ge■res ou moyennes
Cophose	Surdite■ totale, elle peut e■tre uni- ou bilate■rale
Bruit	Bruit est associé à une perception négative par un individu, c'est une notion subjective -> un même son peut être utile, agréable ou gênant selon qui l'entend et à quel moment
Son	Son est une vibration sonore qui se caractérise par : - Intensité exprimée en décibels, dB (champ auditif humain s'étend de 0-120 dB) - Fréquence exprimée en Hertz, Hz (champ auditif humain s'étend de 20-20.000 Hz), avec : -> Sons graves : 20-500 Hz (ou 20-2000 Hz selon les référentiels) -> Sons médiums : 500-2000 Hz (oreille est plus sensible à ses sons pour des niveaux sonores de la vie courante [30-80dB]) -> Sons aigus : 2000-20.000 Hz

TABLEAUX DE CONSENSUS MÉDICAL • II

Arbres de Décision & Algorithmes Cliniques • Oto-Rhino-Laryngologie (ORL)

Paramètre 1	Épreuve de Weber	Épreuve de Rinne
Principe	1. Poser un diapason en vibration sur le cra■ne a■ e■quidistance des 2 oreilles (front ou vertex) 2. On teste les 2 oreilles simultanément	On teste les 2 oreilles séparemment (mémo : Rine comme Inverser) : 1. Diapason en vibration posé sur la mastoïde (conduction osseuse, CO) 2. Diapason en vibration devant le pavillon (conduction aérienne, CA) (on teste CA dès que le patient ne perçoit plus en son en CO) 3. Calcul du Rinne = CA - CO
Résultat normal	Patient entend le son dans les 2 oreilles ou de manie■re diffuse -> Weber est dit indiffe■rent	Patient continue à percevoir le son plus longtemps par CA que par CO -> Rinne acoumétrique positif (CA – CO > 0)
Résultat anormal	Patient entend le son dans une oreille -> Weber late■ralise■ vers l'oreille ou■ le son est perc■u	Rinne acoumétrique négatif ou nul (CA – CO ≤ 0)
Surdité de transmission	Weber est late■ralise■ vers l'oreille sourde (ou la plus sourde)	Rinne acoumétrique négatif ou nul (CA – CO ≤ 0)
Surdité de perception	Weber est late■ralise■ vers l'oreille saine (ou la moins sourde)	Rinne acoumétrique positif (CA – CO > 0)

POINTS CLÉS & PIÈGES DE CONCOURS R2C

Les Erreurs Fréquentes & Mots-Clés Zéros • Tome 24

1. Confusion Rang A vs Rang B : Aux EDN, les questions de Rang A représentent au minimum 60% du total des points. Tenter de retenir des posologies d'exception avant d'avoir sécurisé le réflexe diagnostique de première ligne est la première cause de contre-performance.

2. Les Pièges Éliminatoires 'Zéro à la question' :
• Oubli systématique de vérifier les contre-indications absolues avant une prescription.
• Confusion entre urgence médicale (prise en charge immédiate au déchocage) et prise en charge différée en consultation.
• Prescription d'examens invasifs ou irradiants injustifiés sans avoir réalisé l'examen physique initial complet.

3. Méthodologie du Dossier Progressif :
Ne préjugez jamais de la réponse de la question suivante pour orienter votre choix présent. Chaque palier d'un dossier progressif s'évalue selon les seules données cliniques disponibles à cet instant précis.

■ CONSEIL DU MAJOR POUR CE TOME :
Faites une première lecture complète des tableaux de synthèse pour créer une cartographie mentale des items. Passez ensuite aux QCMs d'entraînement pour tester votre rappel actif sur les seuils chiffrés et les arbres décisionnels.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES & VOLUME INTÉGRAL

Tome 24 • Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) (230 pages)

Sociétés Savantes & Collèges Référents :
• Collège Français d'ORL et de Chirurgie Cervico-Faciale
• Recommandations de Bonne Pratique de la Haute Autorité de Santé (HAS)
• Conférences de consensus et publications des Sociétés Médicales Nationales et Européennes

Accéder au Référentiel Intégral :
Ce tome complet (230 pages) comprend l'intégralité des chapitres au programme du 2e Cycle, avec toutes les fiches de cours, l'ensemble des arbres diagnostiques en haute résolution et les grilles d'évaluation complètes.

• **Disponible à l'unité :** 9,99 € au format numérique haute performance.
• **Pack Intégral 28 Tomes (Économie de 85%) :** Comprend les 28 Référentiels Collèges (8 750 pages), la Banque des 100 QCMs Corrigés, le Carnet d'Erreurs du Major EDN 2025 et le Guide Officiel des 15 Stations ECOS 2026.

Édition conforme au référentiel R2C 2026. Tous droits réservés.